Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0837824-49.2020.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Renata Freires Lima
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Concessão de Tutela de Urgência*, proposta por **Renata Freires Lima** em desfavor de **Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, ambos já qualificados nos autos.

Narra a inicial que a autora é beneficiaria dependente do plano de saúde junto à empresa ré, representado pelo contrato n. 20/6336, de titularidade de seu genitor, Damião Ferreira Lima, desde 20/11/1997 – carteira n. 00512006336000041, CNS n. 704107170519670.

Conta que, conforme laudo médico, a autora é portadora de doença degenerativa denominada Espondilite Anquilosante (CID:M45.0), realizando tratamento periódico desde outubro de 2014.

Aduz que, diante do quadro clínico da autora, o médico responsável pelo tratamento, solicitou à ré, em caráter emergencial, a liberação do medicamento *Certolizumabe Pegol – 400mg* ampolas de 200mg, a ser aplicado no "momento zero", após 15 dias e demais aplicações a cada 4 semanas ou conforme a necessidade da paciente.

Afirma que a ré indeferiu o pedido formulado pelo médico, sob o fundamento de que a solicitação não atendeu as diretrizes de utilização prevista no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Ressalta que já utilizou os seguintes medicamentos: *"Metotrexate 25mg (via oral) e Sulfassalazina (via oral), por 6 meses, porém com efeitos colaterais gastrointestinais; também fez uso de Corticosteróides (alta dose) e Indometacina 200mg (via oral), entre 8/2019 a 12/2019, sem obtenção de resposta; também fez uso de Naproxeno 550mg/dia (via oral), entre 12/2019 a 04/2020, porém, sem remissão do quadro; Hidroxicloroquina (via oral) ainda em uso, mas sem remissão do quadro."* (f. 04).

Assinala que, diante da falta de resposta com o uso dos citados medicamentos, o médico que acompanha a autora há 06 (seis) anos, solicitou – em caráter emergencial – a liberação para o uso do fármaco *Certolizumabe Pegol – 400mg*/2 ampolas de 200mg.

Salienta que o fármaco solicitado pelo médico trata-se de um medicamento de componente especializado, que reduz a taxa de progressão das lesões nas articulações, medida através de radiografia, a qual leva também a uma melhoria da função física, quando administrado em associação com MTX (metotrexato), tratando-se de medicamento de alto custo.

Destaca que de acordo com o laudo médico, a autora demanda 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

(duas) doses de 200mg do medicamento a cada 4 semanas, de forma que o valor pode chegar ao total de R$ 5.940,70 (cinco mil, novecentos e quarenta reais e setenta centavos) mensais.

Afirma que o plano de saúde do qual a autora é beneficiária estabelece cobertura de medicamentos registrados/regularizados na ANVISA, utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos para a segmentação ambulatorial, conforme se verifica do item 4.2, VIII, do respectivo Termo.

Assim, afirma que, não tendo condições financeiras de arcar com as despesas do medicamento solicitado, não resta alternativa à autora senão buscar a tutela jurisdicional, a fim de obrigar a empresa ré a promover o seu completo tratamento de saúde, sendo compelida a custear e fornecer o medicamento *Certolizumabe Pegol – 400mg*/2 ampolas de 200mg, para o tratamento da doença Espondilite Anquilosante que acomete a autora.

Por estes motivos, requer a justiça gratuita; antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado à requerida que ofereça e custeie o medicamento *Certolizumabe Pegol 400mg*, contendo 2 ampolas de 200mg, a ser efetuado da seguinte forma: (A) a primeira dose imediatamente, que representa a 1ª aplicação, denominada "momento zero"; (B) a segunda dose após 15 dias; (C) as demais doses a cada 4 semanas. No mérito, requer a procedência do pedido a fim de condenar a ré à obrigação de custear e ofertar o medicamento *Certolizumabe Pegol 400mg*, contendo 2 ampolas de 200mg, a cada 4 semanas, até disposição médica em contrário, ratificando a tutela deferida e ainda a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Juntou documentos às f. 15-135.

Em decisão de f. 136-144, deferiu-se o pleito de justiça gratuita em favor da parte autora, concedeu-se a tutela de urgência e determinou-se a citação da ré designando audiência de conciliação.

A ré foi citada (f. 207) e interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão (f. 209-211), sendo negado provimento ao citado agravo de instrumento, conforme ofício de f. 452-465.

A ré apresentou contestação às f. 227-253, onde impugnou a justiça gratuita concedida à autora. No mérito, aduz que o contrato firmado entre as partes é regulamentado pela Lei 9.656/98, de modo que não podem escapar àquilo que é normatizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme art. 4º, III e XXIX, da Lei Federal nº 9.961/20007. Destaca que o normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, determina em quais situações clínicas determinado procedimento/medicamento deve ser realizado/utilizado e autorizado pelas Operadoras de Saúde, não sendo indicado e aceitável a autorização fora dos critérios das Diretrizes de Utilização da Agência Reguladora. Sustenta que no caso do autora, a prescrição do medicamento denominado *Certolizumabe Pegol*, não se enquadra nas diretrizes de utilização n. 65 da ANS. Assevera que a autora não cumpriu com um dos requisitos previstos na Diretriz de Utilização nº 65, qual seja, *"pacientes com índice de atividade da doença igual ou maior do que 4 pelo BASDAI (Índice Bath de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante) ou igual ou maior do que 4,5 pelo ASDAS (Escore de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante), refratários ao tratamento convencional*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

por um período mínimo de três meses com doses plenas de pelo menos dois antiinflamatórios não hormonais (AINHs) e, nos pacientes com doença predominantemente periférica com ausência de resposta à sufassalazina ou ao metotrexato, por período adicional de 3 meses". Salienta que a ré não possui obrigatoriedade de autorização e custeio do medicamento denominado Certolizumabe Pegol, ora requerido, pois resta pormenorizadamente demonstrado que o medicamento está fora das Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde – ANS. Afirma que a autora tinha plena ciência das limitações da cobertura na ocasião da assinatura do contrato, não estando facultada a ela a livre escolha do serviço. Sustenta que a única cobertura obrigatória de medicamento para uso domiciliar se restringe a pacientes que estão em tratamento contra o câncer, o que não é o caso dos autos.

Discorreu sobre a taxatividade do rol de eventos e procedimentos da ANS e defende a não configuração de caso de urgência ou emergência. Ao final requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos às f. 254-426.

Audiência de conciliação realizada, sem acordo entre as partes (f. 430-431).

Impugnação à contestação às f. 443-451.

Intimadas para especificarem as provas pretendidas (f. 466-468), a parte requerida pugnou pela prova testemunhal, depoimento pessoal da autora, prova documental e pericial (f. 469-471). O autor requereu o julgamento antecipado da lide (f. 472-475).

Pela decisão de f. 476-479 determinou-se que a autora comprovasse seus rendimentos, o que foi feito às f. 485-532.

O feito foi saneado às f. 549-555, ocasião em que rejeitou-se a impugnação à justiça gratuita. Fixou-se os pontos controvertidos, deferiu-se a prova pericial e postergou-se a análise da necessidade da prova testemunhal.

Manifestação da parte autora às f. 572-574, requerendo a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, ao argumento de que o médico que lhe assiste, prescreveu outro medicamento do qual a ré autorizou o procedimento, não havendo mais necessidade das razões que motivaram a presente ação.

O réu foi intimado acerca do pedido feito pela autora, oportunidade em que não concordou com a extinção do feito sem julgamento de mérito, requerendo o prosseguimento até seus ulteriores termos (f. 586-587).

Despacho de f. 588, determinando o prosseguimento do feito com realização da prova pericial.

O laudo pericial foi juntado às f. 605-611, do qual as partes apresentaram manifestações de f. 612-613 (autora) e f. 617-622 (requerida).

Relatados. **DECIDO.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Trata-se de *Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Concessão de Tutela de Urgência*, proposta por **Renata Freires Lima** em desfavor de **Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, ambos já qualificados nos autos.

O feito admite o julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a prova oral requerida pela ré às f. 469-471.

Análise da petição de f. 572-574 (extinção do feito sem julgamento de mérito)

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, resta analisar o pedido de extinção do feito sem julgamento de mérito, formulado pela parte autora às f. 572-574.

Para tanto, alega a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o médico que lhe assiste, prescreveu outro medicamento do qual a ré autorizou o procedimento, não havendo mais necessidade das razões que motivaram a presente ação.

A requerida, devidamente instada a manifestar sobre esse pedido, apresentou discordância, requerendo o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos (f. 586-587).

Na hipótese, não há falar em perda superveniente do interesse de agir pelo fato da médica que atende a paciente ter prescrito outro fármaco em detrimento do qual fora pleiteado na inicial, haja vista que o fornecimento de medicamento ocorreu por força de decisão judicial em sede de tutela de urgência, portanto, de natureza precária, não ensejando a perda do objeto.

Ademais, o interesse decorre da recusa ao fornecimento do medicamento, sendo que os reflexos patrimoniais da cobertura, ou não, permanecem mesmo após a interrupção do tratamento, referindo-se ao período cuja cobertura foi concedida, em sede de tutela provisória.

Nesse sentido:

> "APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À NECESSITADA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. **O fato de o pedido inicial ter sido atendido, a partir do deferimento da tutela antecipada pleiteada, com posterior suspensão do tratamento pleiteado, podendo ser retomado, não equivale à perda do objeto da ação, cabendo o exame da legalidade da sentença, inclusive para fins de sucumbência**..." (TJ-RS - REEX: 70066454471 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 10/09/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2015).

Deste modo, **indefiro** o pedido de extinção do feito sem resolução de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

mérito, formulado pela autora às f. 572-574.

Mérito

Da obrigação de Fazer

Afirma a parte autora, em suma, que é beneficiaria dependente do plano de saúde junto à empresa ré, e é portadora de doença degenerativa denomina Espondilite Anquilosante (CID:M45.0), realizando tratamento periódico desde outubro de 2014. Conta que foi prescrito pelo médico especialista o medicamento Certolizumabe Pegol – 400mg ampolas de 200mg, a ser aplicado no "momento zero", após 15 dias e demais aplicações a cada 4 semanas ou conforme a necessidade da paciente, sendo que a ré indeferiu o pedido formulado pelo médico, sob o fundamento de que a solicitação não atendeu as diretrizes de utilização prevista no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sustenta que o medicamento possui alto custo, não tendo a autora condições de arcar com as despesas do tratamento, não restando alternativa senão buscar a tutela jurisdicional, a fim de obrigar a empresa ré a promover o seu completo tratamento de saúde, sendo compelida a custear e fornecer o medicamento *Certolizumabe Pegol – 400mg*/2 ampolas de 200mg, para o tratamento da doença Espondilite Anquilosante que acomete a autora.

Em contestação a ré defendeu, em síntese, que a prescrição do medicamento denominado Certolizumabe Pegol, não se enquadra nas diretrizes de utilização n. 65 da ANS, que a autora tinha plena ciência das limitações da cobertura na ocasião da assinatura do contrato, não estando facultada a ela a livre escolha do serviço, bem como que a única cobertura obrigatória de medicamento para uso domiciliar se restringe a pacientes que estão em tratamento contra o câncer, o que não é o caso dos autos.

Como é sabido, a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, parágrafo 2º:

> *"Art. 3. (...)*
> *§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."*

Se assim o é, os contratos envolvendo relação de consumo têm de ser interpretados à luz do novo paradigma protetivo e de princípios tais como: "vulnerabilidade do consumidor" (art. 4ª, I, do CDC); "da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, do CDC), entre outros, competindo ao julgador, no caso concreto, ponderar os fatos apresentados, de sorte a tomar a decisão que mais se aproxima do justo. Demais disso, em caso de conflito entre o interesse do usuário e o interesse do fornecedor, o contrato deverá ser interpretado favoravelmente ao consumidor (pró-consumidor) segundo a disposição constante do artigo 47.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

De razoável compreensão que ao contratar os denominados planos de saúde, busca-se mais que simples consultas e exames laboratoriais, mas também, a garantia de assistência médica de qualidade, abrangendo todo o tratamento e recuperação da enfermidade, admitindo-se, no máximo, distinções quanto ao conforto das acomodações hospitalares oferecidas aos contratantes, variável da simples enfermaria às suítes de luxo, que alguns conseguem pagar.

No caso dos autos, a controvérsia reside na negativa da parte requerida em fornecer o medicamento recomendado por médico especialista, credenciado da referida instituição, qual seja, o medicamento "*Certolizumabe Pegol*", **conforme relatório médico de f. 55 e 56 e formulário de solicitação de f. 57-58:**

IREDO

Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares

A

UNIMED CAMPO GRANDE

REF.: RENATA FREIRES LIMA

0 051 200633600004 1

Relato para os devidos fins, que a Sra. RENATA FREIRES LIMA, 35 anos, faz tratamento comigo desde 10/2014, devido ao fato de ser portadora de Espondilite Anquilosante (CID:M45.0). Me procurou com quadro de dores generalizadas, edema e inflamação de articulações, rigidez de articulações, dor lombar baixa de caráter noturno, cansaço físico, o qual aos exames solicitados apresentou os seguintes resultados:

10/2014 FAN 1/320, Anti RO Positivo;

11/2014 PCR 5,1, FAN 1/320, Triglicérides 159;

10/2016 FAN 1/640, Ressonância de coluna lombar: saliência disal L5-S1/compressão de saco dural;

11/2016 TC de tórax: nódulo calcificado, granuloma, vidro fosco lobo superior pulmão esquerdo;

04/2020 Anti RO 47, FAN 1/640, DNA 1,4;

09/2020 FAN 1/320, Anti RO Positivo, Hepatite B Positivo, HOMA Beta 345, Espirometria: distúrbio ventilatório obstrutivo leve, Cintilografia óssea: hipercapitação em Sacroiliacas, Ressonância de Sacroiliacas: Sacroileite, RX de calcâneos: Esporão;

PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

10/2016 Infiltração com Triancinolona em Sacroiliacas;

08/2020 Infiltração com Triancinoloma em coluna torácica, lombar e sacroiliacas com Triancinolona;

MEDICAMENTOS UTILIZADOS: Metotrexate 25mg VO, Sulfassalazina VO- 6 meses, porém com efeitos colaterais gastrointestinais, Corticosteróides (altas doses), Indometacina VO 200MG/dia desde 08/2019 a 12/2019 sem resposta, Naproxeno VO 550mg/dia desde 12/2019-04/2020/contínuo, sem remissão do quadro, Hidroxicloroquina VO- ainda em uso –sem remissão.

Devido ao quadro acima exposto, e as condições em que a mesma se encontra, solicito liberação em caráter **EMERGENCIAL** de Certolizumab Pegol –400mg/2 ampolas de 200mg, com o seguinte protocolo de administração.

1ª aplicação: momento zero;

2ª aplicação: dose de ataque- após 15 dias da realização da 2ª;

Demais aplicações a cada 4 semanas ou conforme a necessidade da mesma;

São aplicadas 2 ampolas de 200mg a cada aplicação.

BASDAI 8 **PESO** 89KG **ALTURA** 1, 69 cm

Sem mais, agradeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

IREDO - Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares
Rua São Nicásio, 124 - Mooca - CEP 03128-050

IREDO

Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares

PRESCRIÇÃO

RA. RENATA FREIRES LIMA

- dieta geral

- Certolizumab pegol------200mg /Cimzia } 2 Ampolas SC

3 - Sinais vitais, início, meio e fim do item 02 }

4- Em caso de processo alérgico retirar item 02

5 – Qualquer dúvida ou intercorrência entrar em contato pelo telefone: (11) 2021-6869

SP- 24/09/2020

IREDO - Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares
Rua São Nicásio, 124 - Mooca - CEP 03128-050
Tel.: (55 11) 2021.6869 - Cel.: (55 11) 98154-0308 - São Paulo - SP
e-mail: contato@iredo.com.br
www.iredo.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE IMUNOBIOLÓGICOS PARA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

1ª SOLICITAÇÃO IMUNOBIOLÓGICO

OBS: Todos os itens deverão ser preenchidos e prescrição anexada

MEDICAMENTO SOLICITADO

Princípio Ativo: Certolizumabe Pegol — Dose: 200 mg

Posologia: Primeiro ano, após 15 dias - 2 ezda 4 sem 2x 35

DADOS DO PACIENTE

Nome: Renata Freires Lima — Código Beneficiário: 0052006336000041

Idade: 35 anos — Sexo: F — Peso Atual: 89 kg — Altura: 1,69 cm — IMC

INDICAÇÃO CLÍNICA

[X] Espondilite Anquilosante [ ] Outra:

CARACTERÍSTICA DA DOENÇA

Ano diagnóstico da doença: 2014

Tempo de acompanhamento com o médico prescritor: 6 anos

Fator Reumatóide: Negativo

HLA - B27

Comprometimento: [ ] Axial [ ] Ambos [ ] Periférico

Triagem: PDD [X] não reator [ ] reator fraco [ ] reator forte

Critérios de diagnóstico da doença: Dor lombar melhora com exercício e não alivia pelo repouso, limitação de coluna nos planos frontal e sagital, Expansibilidade torácica.

Exames de imagem: Gastroscopia: hipercapilarização em sacroiliacas, RNM de sacroilíacas sacroiliite;

RX de Tórax: Data: __/__/__

HBSAg: Negativo data: 08/2020

AntiHBC: data: __/__/__

AntiHBS: Negativo data: 08/2020

Vacinações realizadas:

MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES

[ ] Síndrome Sjogren [ ] Episclerite [ ] Anemia

[ ] Uveite [ ] Nódulos reumatóides [ ] Lesão pele psoriática

[ ] outros:

MANIFESTAÇÕES EXTRA ESQUELÉTICA AXIAL

[ ] Uveite [ ] Uretrite/cervicite [ ] Outras astrites - Locais: [ ] Outras:

CONTRAINDICAÇÕES AO USO DE IMUNOBIOLÓGICO

[ ] ICC NYHA III/IV [ ] Gestação/Lactante [ ] Infecção Aguda [ ] Doença desmielinizante [ ] Neoplasia < 10a

EVOLUÇÃO DA DOENÇA - OUTRAS INFORMAÇÕES

Portador de EA - sem efetividade ao tratamento de base

TRATAMENTOS PRÉVIOS

Princípio Ativo	Dose Prescrita	Tempo de Uso: Início (mm/aa)	Tempo de Uso: Fim (mm/aa)	Motivo da Suspensão Tratamento
AINH				
Celecoxibe	200mg	09/2020		em uso
Celecoxibe	20	09/2020		em uso

Unimed Campo Grande — www.unimedcg.coop.br

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE IMUNOBIOLÓGICOS PARA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

1ª SOLICITAÇÃO IMUNOBIOLÓGICO

OBS: Todos os itens deverão ser preenchidos e prescrição anexada

Princípio Ativo	Dose Prescrita	Tempo de Uso: Início (mm/aa)	Tempo de Uso: Fim (mm/aa)	Motivo da Suspensão Tratamento
CORTICÓIDES				
Prednisona	3mg/dia	09/20	em uso	09/2020 - em uso
DMCD SINTÉTICAS				
Hidroxicloroquina	400mg			
Sulfassalazina	3g/dia	10/2019	09/2025	efeitos colaterais
IMUNOBIOLÓGICOS ANTERIORES				
Nenhum				

ÍNDICE DE ATIVIDADE DE DOENÇA ATUAL - BASDAI — DATA DA AVALIAÇÃO: 22/09/2020 — VALOR

VARIÁVEL (dados relativos nos últimos 7 dias - 1 semana) Escala: 0 (nenhum) 10 (intenso)

1 - Grau de fadiga ou cansaço (0 - 10cm)	10
2 - Grau total de dor no pescoço, nas costas e no quadril (0 - 10 cm)	10
3 - Grau total de dor e edema nas outras articulações (0 - 10 cm)	10
4 - Grau total de desconforto ao toque/compressão nas áreas doloridas (0 - 10 cm)	10
5 - Intensidade da rigidez matinal, desde o despertar (0 - 10cm)	10
6 - O tempo de duração da rigidez matinal desde o despertar: (0) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)	10

0h (=0) 24min (=2) 1h (=5) 1h:36min (=8) 2h ou + (=10)

http://east-kent-rheumatology.co.uk/wordpress/basdai-calculator/ — SCORE BASDAI: 8

INFORMAR CRITÉRIO DE RESPOSTA MÍNIMA PARA MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO

Não se enquadra- início de tratamento.

DATA PREVISTA PARA REAVALIAÇÃO DO PACIENTE: 22/2020

DADOS DO MÉDICO

Nome: Joly Bontempi Carvalho — CRM: 60377

Especialidade: Reumatologia — Tel. Contato: (67) 20026869

DR. BERGSON BONTEMPI CARVALHO — REUMATOLOGIA E OSTEOPOROSE — CRM 60377

Assinatura e carimbo do médico assistente — Data 22.09.2020

Unimed Campo Grande — www.unimedcg.coop.br

A parte ré, por sua vez, negou o tratamento a requente, ao argumento de que o medicamento pleiteado não atende as Diretrizes e Utilização (DUT) prevista no rol de cobertura (rol de medicamentos e eventos de saúde) da Agencia Nacional de Saúde Suplementar, nos termo da RN-ANS n. 428/2017 (f. 74-75):

19/10/2020 — Email – Renata F. Lima – Outlook

Unimed Campo Grande — NAE-MOD.01.06 NEGATIVA, DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO F. 1

Rua Goiás, 695, 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS, T (067) 3389-2600

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO – MOTIVO E INFORMAÇÕES
(fornecida de acordo com o art. 10 da Resolução Normativa RN-ANS nº 395/2016).

Número do Protocolo de Solicitação: 31285120201005000392
Local e Data: Campo Grande, MS, 05/10/2020.

Dados da Parte Beneficiária

Nome		Data de Nascimento
Renata Freires Lima		4/03/1985
Número da Carteira: 0051 2006336000041	CPF/MF: 003.497.881-03	Data de Adesão/Contratação: 20/11/1997
Número do Plano na ANS: 200801	Abrangência: Nacional	Acomodação: Enfermaria
Tipo de Contrato: [X] Individual ou Familiar; [ ] Coletivo Empresarial; [ ] Coletivo por Adesão; [ ] Não Regulamentado; [ ] Regulamentado; [X] Adaptado	Contratante: Damião Ferreira Lima	

Dados da Solicitação

Número do Pedido Eletivo	CID	
2020/01226577	-	
Descrição do Procedimento TUSS: TERAPIA IMUNOBIOLOGICA SUBCUTANEA (POR SESSAO) AMBULATORIAL(COM DIRETRIZ DEFINIDA PELA ANS - Nº 65); CIMZIA 200MG SOL INJ CT 2 SER VD (CERTOLIZUMABE PEGOL 200 MG)	Código TUSS: 20104421	Quantidade: 03

Diretriz de Utilização (DUT) Não Observada na Solicitação Acima Referida

Anexo II da RN-ANS nº 428/2017	Descrição da Diretriz Não Atendida
Item número 65	Anexo

Cara beneficiária,
Informamos que recebemos de seu médico assistente a solicitação do medicamento acima discriminado para tratamento de Espondilite Anquilosante. A solicitação passou por análise de consultoria médica especializada que emitiu parecer desfavorável, tendo em vista que **não atende as Diretrizes de Utilização (DUT) prevista no rol de cobertura (rol de procedimentos e eventos de saúde)** da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da RN-ANS nº 428/2017.

Unimed Campo Grande — NAE-MOD.01.06 NEGATIVA, DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO F. 2

Rua Goiás, 695, 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS, T (067) 3389-2600

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:

Conforme define a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, **rol de cobertura** (ou rol de procedimentos de cobertura obrigatória) é uma listagem na qual constam os procedimentos (exames, cirurgias, etc...) que obrigatoriamente deverão ser cobertos pelas operadoras de planos de saúde. Este rol de procedimentos está previsto e atualizado pela RN-ANS nº 428/2017, e constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória a ser observada pelos planos de saúde.

Ademais, a mesma RN-ANS nº 428/2017 elenca as Diretrizes de Utilização (DUT), que estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados em seu anexo. **No caso, a Vossa solicitação não se enquadra na Diretriz de Utilização (DUT) indicada no quadro acima**, disso resultando, portanto, a ausência de sua cobertura. Vejamos, a referida Diretriz estabelece o seguinte para o tratamento de **Espondilite Anquilosante**: *pacientes com índice de atividade da doença igual ou maior do que 4 pelo BASDAI (Índice Bath de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante), refratários ao tratamento convencional* **por um período mínimo de três meses com doses plenas de pelo menos dois antiinflamatórios não hormonais (AINHs)** *e, nos pacientes com doença predominantemente periférica com ausência de resposta à sulfassalazina ou ao metotrexato, por período adicional de 3 meses.*

Conforme informações prestadas pelo seu médico assistente em formulário específico, os critérios acima descritos não foram preenchidos para fornecimento do medicamento **CIMZIA 200MG SOL INJ CT 2 SER VD (CERTOLIZUMABE PEGOL 200 MG)** pela Unimed Campo Grande.

Em atenção ao que determina a Lei nº 9.656/98 em seu art. 16, inciso VI, o contrato firmado por Vossa Senhoria contém cláusula que prevê as hipóteses de **exclusão de cobertura**, no sentido de que **estão excluídos de cobertura do plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS**.

Todos os conceitos e condições acima expostos constam de forma explícita nas cláusulas que integram o Contrato firmado por Vossa Senhoria.

Pelas razões acima expostas, não houve autorização de atendimento da solicitação apresentada por Vossa Senhoria. A legislação e as normas citadas acima podem ser consultadas no sítio oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br).

Na expectativa de termos prestado os esclarecimentos necessários, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,

Vera Lúcia de Melo Nantes — Gerente Operações em Saúde — Unimed Campo Grande - MS

Pois bem. Sabe-se que na atualidade, já não é aceitável alegar-se o *pacta sunt servanda* para legitimar cláusulas contratuais abusivas, porquanto a relação jurídica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

que lhes deu origem é regulada pelo Código de Proteção e de Defesa do Consumidor e, frente a tais disposições, as chamadas cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, cujo reconhecimento poderá ocorrer a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; muito mais se inseridas nos chamados contratos de adesão.

No presente caso foi realizada a prova pericial (f. 605-611), tendo a expert do juízo afirmado, que a autora é portadora de espondilite anquilosante, causando diminuição da mobilidade e dor do segmento, cuja doença é autoimune e progressiva, gera muito sofrimento e incapacidade, bem como ressaltou que ***"o tratamento médico foi prescrito de forma correta****, sob pena de piora de seu quadro clínico se não instituído"* (f. 610).

A propósito, vide conclusão da perita de f. 610:

VII. CONCLUSÃO

20. Pelo exposto, concluo que:

(i) a periciada é portadora de espondilite anquilosante, causando diminuição da mobilidade e dor do segmento;

(ii) a doença é autoimune e progressiva;

(iii)o tratamento médico foi prescrito de forma correta, sob pena de piora de seu quadro clínico se não instituído.;

(iv) a dispensação destas medicações tem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde de acordo com o rol da Agência Nacional de Saúde.

Como visto, a expert **ressaltou, ainda, que o medicamento solicitado (Certolizumabe Pegol) possui cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, de acordo com o rol da Agência Nacional de Saúde**, fato que, inclusive, pode ser verificado no site (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-incorpora-tecnologia-ao-rol), conforme respostas aos quesitos de f. 610:

3. A prescrição para utilização do medicamento solicitado para o caso específico da periciada estava contemplada em bula e cumpre os pré-requisitos presentes nas Diretrizes de Utilização estabelecidas pela Agência Nacional da Saúde –ANS?
Resposta: Sim, a prescrição das medicações utilizadas pela periciada seja o certolizumabe ou adalimumabe está contemplada em bula e cumpre os pré-requisitos presentes nas Diretrizes de Utilização estabelecidas pela Agência Nacional da Saúde –ANS.

4. O procedimento terapia com Certolizumabe para tratamento da periciada é de cobertura obrigatória pelo Rol de Procedimento da ANS?

Resposta: Sim, a cobertura é obrigatória pelo Rol de procedimentos da ANS.

5. Tratando-se de uma doença crônica e de evolução lenta, o tratamento foi solicitado de forma ambulatorial ou foi prescrito em situação caracterizada como urgência ou emergência, segundo critérios do CFM?

Resposta: A medicação foi solicitada de forma ambulatorial, sob pena de piora progressiva do quadro, caso negada.

6. Existe cobertura contratual para fornecimento de medicamento para tratamento ambulatorial de espondilite anquilosante ou as cláusulas contratuais preveem exclusão desta cobertura?

Resposta: Sim, existe cobertura contratual para fornecimento de medicamento para tratamento ambulatorial de espondilite anquilosante, regulamentada pela ANS (Agência Nacional de Saúde)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

Ademais, ainda que o medicamento, à época da propositura da ação, não estava previsto no rol da ANS, o fato de inexistir previsão de cobertura para o tratamento em questão no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não torna legítima a recusa, **haja vista que o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo**, sendo mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, pois busca delimitar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão dos demais.

Não se presta, pois, para excluir direitos do consumidor, mas apenas para hierarquizar certos procedimentos como essenciais, de modo que não sejam passíveis de exclusão.

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 não proíbem o estabelecimento de restrições aos direitos dos consumidores. No entanto, a permissão em tela não é absoluta. É limitada pela própria lei e pelos princípios que regem as relações de consumo, sendo certo que o artigo 51 do CDC estabelece serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (inciso IV).

O § 1º do citado artigo, por sua vez, registra ser presumidamente exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (inciso II).

Igualmente, em se tratando de relação de consumo, é importante mencionar o teor do art. 6º, V, do CDC, qual seja, é direito básico do consumidor "*a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas*".

A aplicação das referidas disposições legais ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura quanto ao procedimento necessitado pela parte autora pelo simples fato de não constar em rol da ANS.

O contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado pelas partes dos autos em epígrafe exclui, em sua cláusula 5.28, "*Procedimentos não relacionados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento* " – f. 304. **Ocorre que é certo que o contrato pode dispor sobre as patologias cobertas e não sobre o tipo de tratamento. O médico não pode ser impedido de escolher o tratamento mais adequado, uma vez que pretende a preservação da vida do paciente, bem como a melhora na qualidade da existência, com fundamento, inclusive, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).**

E no presente caso, conforme bem ressaltado pela perita nomeada judicialmente, o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a autora tem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, de acordo com o rol da ANS (f. 610):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

6. Existe cobertura contratual para fornecimento de medicamento para tratamento ambulatorial de espondilite anquilosante ou as cláusulas contratuais preveem exclusão desta cobertura?

Resposta: Sim, existe cobertura contratual para fornecimento de medicamento para tratamento ambulatorial de espondilite anquilosante, regulamentada pela ANS (Agência Nacional de Saúde)

VII. CONCLUSÃO

20. Pelo exposto, concluo que:

(i) a periciada é portadora de espondilite anquilosante, causando diminuição da mobilidade e dor do segmento;

(ii) a doença é autoimune e progressiva;

(iii)o tratamento médico foi prescrito de forma correta, sob pena de piora de seu quadro clínico se não instituído.;

(iv) a dispensação destas medicações tem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde de acordo com o rol da Agência Nacional de Saúde.

Assim, não há como a requerida se valer da Resolução da ANS para afastar o fornecimento do tratamento pleiteado pelo autor, ainda mais quando foi requisitado por médico que acompanham o caso da parte autora desde o início do tratamento.

O nosso e. TJMS já se manifestou sobre a questão, confira-se:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ELETROCONVULSOTERAPIA – PACIENTE COM DEPRESSÃO BIPOLAR REFRATÁRIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELOS ESPECIALISTAS SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ***Às operadoras de planos de saúde cabe apenas estabelecer as enfermidades a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerados essenciais e em conformidade com recomendação médica específica.*** *Não havendo no contrato previsão de exclusão de cobertura da doença que acomete o apelado, qual seja, Depressão Bipolar Refratária, não pode a apelante negar-se a fornecer o tratamento do qual aquele necessita pelo simples fato de não constar no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), uma vez que possui caráter meramente exemplificativo. (TJMS. Apelação Cível n. 0800104-98.2019.8.12.0028, Bonito, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 30/06/2021, p: 07/07/2021)*

Não fosse isso, compete aos profissionais médicos à análise da adequação dos procedimentos a serem utilizados para o tratamento de uma patologia, não sendo razoável que a cooperativa se imiscuir na escolha do tratamento a ser utilizado para o acompanhamento da doença que acomete seu associado, limitando-se a dizer que o mesmo é eletivo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

*APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E DE INTERVENÇÃO COM PROFISSIONAIS QUE POSSUAM ESPECIALIDADE (REABILITAÇÃO COM MÉTODO ABA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO – DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – COBERTURA DEVIDA SEM LIMITAÇÕES – OPTANDO A PARTE AUTORA EM REALIZAR O TRATAMENTO EM CLINICA DE LIVRE ESCOLHA, OS GASTOS COM FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DEVERÃO SER REEMBOLSADOS DE ACORDO COM OS LIMITES DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0838079-12.2017.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 10/05/2022, p: 11/05/2022).*

Outrossim, não merece acolhimento a argumentação da ré, no sentido de que a autora não cumpriu com um dos requisitos previstos na Diretriz de Utilização nº 65, qual seja, "*pacientes com índice de atividade da doença igual ou maior do que 4 pelo BASDAI (Índice Bath de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante) ou igual ou maior do que 4,5 pelo ASDAS (Escore de Atividade da Doença para Espondilite Anquilosante), refratários ao tratamento convencional por um período mínimo de três meses com doses plenas de pelo menos dois antiinflamatórios não hormonais (AINHs) e, nos pacientes com doença predominantemente periférica com ausência de resposta à sufassalazina ou ao metotrexato, por período adicional de 3 meses*", **pois, conforme relatório médico de f. 55, a autora apresenta índice BASDAI 8 e realizou tratamento com período superior a três meses, com utilização dos medicamentos Indometacina 200mg via oral, Naproxeno 550mg via oral, Sufassalazina 25mg via oral e Metatrexato via oral (f. 55):**

09/2020 FAN 1/320, Anti RO Positivo, Hepatite B Positivo, HOMA Beta 345, Espirometria: distúrbio ventilatório obstrutivo leve, Cintilografia óssea: hipercapitação em Sacroiliacas, Ressonância de Sacroiliacas: Sacroileite, RX de calcâneos: Esporão;

PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

10/2016 Infiltração com Triancinolona em Sacroiliacas;

08/2020 Infiltração com Triancinoloma em coluna torácica, lombar e sacroiliacas com Triancinolona;

MEDICAMENTOS UTILIZADOS: Metotrexate 25mg VO. Sulfassalazina VO- 6 meses, porém com efeitos colaterais gastrointestinais, Corticosteróides (altas doses), Indometacina VO 200MG/dia desde 08/2019 a 12/2019 sem resposta, Naproxeno VO 550mg/dia desde 12/2019-04/2020/contínuo, sem remissão do quadro, Hidroxicloroquina VO- ainda em uso –sem remissão.

Devido ao quadro acima exposto, e as condições em que a mesma se encontra, solicito liberação em caráter **EMERGENCIAL** de Certolizumab Pegol –400mg/2 ampolas de 200mg, com o seguinte protocolo de administração:

1ª aplicação: momento zero;

2ª aplicação: dose de ataque- após 15 dias da realização da 2ª;

Demais aplicações a cada 4 semanas ou conforme a necessidade da mesma;

São aplicadas 2 ampolas de 200mg a cada aplicação.

DR. SERGIO BONTEMPI LANZOTTI REUMATOLOGIA OSTEOPOROSE CRM-MS

BASDAI 8 PESO 89KG **ALTURA** 1, 69 cm

Sem mais, agradeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.

Assim, verificando-se que o medicamento era indicado à parte autora por médico especialista que a acompanhava, que inclusive referido fármaco foi incluído no rol obrigatório da ANS, além de que a autora já fez o uso de outros medicamentos, cumprindo os requisitos previstos na Diretriz de Utilização nº 65, conclui-se, portanto, ilícita a recusa da requerida Unimed em não fornecer o medicamento requisitado por médico especialista para melhora/manutenção nas condições de vida da requerente, impondo-se a procedência do pedido de obrigação de fazer, para o fim de obrigar a ré a fornecer o medicamento, *Certolizumabe Pegol*, conforme prescrição médica.

Dispositivo

Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** os pedidos formulados na inicial por **Renata Freires Lima** em face de **Unimed Campo Grande MS – Cooperativa de Trabalho Médico**, para o fim de **condenar** a ré em **obrigação de fazer** consistente ao fornecimento/custeio do medicamento *Certolizumabe Pegol 400mg* 2 ampolas de 200mg a cada aplicação à autora, nos termos da prescrição médica de f. 55, até que o profissional médico determine interrupção do tratamento indicado.

Em razão do julgamento procedente do pedido inicial, **ratifica-se a tutela deferida na decisão de f. 136-144, tornando-a definitiva.**

Ante a sucumbência, **condeno a ré** ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Independente do prazo recursal, expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais em prol da perita nomeado pelo juízo, observando-se os dados bancários informados à f. 605.

Tanto que transitada em julgado a presente sentença, em nada sendo requerido, com as cautelas de estilo, arquivem-se com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 20/07/2023 às 18:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0837824-49.2020.8.12.0001 e código hFiXNjEM.